



霍乱

2024年12月5日 | 阅读时间 12 分钟 (3371 字)

[English](#)

[العربية](#)

[Français](#)

[Русский](#)

[Español](#)

重要事实

- 霍乱是一种严重腹泻病，若不加治疗，可在数小时内使人丧命。快速获得治疗至关重要。
- 研究人员估计，霍乱每年导致全世界大约130万至400万病例及2.1万至14.3万例死亡(1)。
- 大多数感染者无症状或仅有轻微症状，可口服补液治疗。重症病例需要静脉输液、口服补液和使用抗生素。
- 人们获得安全饮用水、基本环境卫生和个人卫生设施对预防霍乱至关重要。
- 口服霍乱疫苗可以帮助预防和控制霍乱。

概述

霍乱是一种急性腹泻感染，由摄入受到霍乱弧菌污染的食物或水引起。这是一个全球性公共卫生威胁，表明存在不平等和未能实现社会经济发展。获得安全饮用水、基本环境卫生和个人卫生设施对预防霍乱和其他水传播疾病至关重要。

大多数感染者仅有轻微或普通症状，可口服补液治疗。但是，这种疾病可能进展迅速，因此迅速开始治疗对挽救生命至关重要。病情严重的患者需要静脉输液、口服补液和抗生素。

各国需要强有力的流行病学和实验室监测，以迅速发现和监测疫情并指导应对。

症状

该病可引起严重急性水样腹泻，如不及时治疗，可在几小时内致人死亡。大多数感染霍乱弧菌的人不会出现症状，但仍会通过粪便传播细菌1-10天。感染后12小时至5天出现症状(2)。

大多数患者症状轻微或中等。少部分患者会出现严重急性水样腹泻，并伴有威胁生命的脱水。

历史

霍乱已经被发现了好几个世纪。十九世纪记录了第一次大流行，或全球流行。自那之后，全世界共发生六次大流行，造成数百万人死亡。目前的（第七次）大流行于1961年始于南亚，迄今还在影响全球人口。

霍乱弧菌菌株

只有O1和O139两个血清群会引起霍乱暴发。最近所有霍乱疫情均由霍乱弧菌O1引起。霍乱弧菌O139过去曾在亚洲引起疫情，但最近仅在零星病例中发现。两种血清型引起的疾病并无差异。

流行病学、危险因素与疾病负担

一些国家定期发生霍乱疫情。其他国家的暴发不那么频繁，每次暴发之间可能间隔数年。霍乱与难以获得安全饮用水和基本环境卫生设施以及不良卫生习惯有关。原因可能是冲突、人口流离失所、气旋、洪水或干旱等气候事件以及缺乏对维护和改善饮用水、环境卫生和个人卫生服务和基础设施的投资。

向世卫组织报告的霍乱病例数目在过去几年持续增加。2023年，45个国家向世卫组织报告了535 321例病例和4 007例死亡(3)。这些数字与研究人员估计的数字之间的差异可能是由于监测系统有限，以及由于担心对贸易和旅游业的影响而漏记。

预防和控制

预防和控制霍乱涉及加强监测、改善水、环境卫生和个人卫生、增加风险沟通和社区参与、改善获得优质治疗的机会以及开展口服霍乱疫苗接种行动。

监测

霍乱监测应成为综合疾病监测系统的一部分。这包括及时报告、数据分析、数据解读和从地方到全球各级分享信息。快速诊断检测有助于早期发现可能的霍乱暴发，但确认需要通过培养、血清凝集试验或聚合酶链反应法进行实验室检测。

面临霍乱风险或受霍乱影响的国家应根据经修订的全球霍乱控制专题小组的建议加强监测系统，以迅速发现和应对疫情。

[有关全球霍乱控制专题小组建议的更多信息](#)（英文）

水、环境卫生和个人卫生项目干预措施

控制霍乱的长期解决方案在于经济发展以及安全饮用水、基本环卫设施和良好个人卫生习惯的普及。水、环境卫生和个人卫生项目的干预措施有助于预防包括霍乱在内的许多水传播疾病，并有助于实现可持续发展目标。在疫情暴发期间，落实水卫项目可以减少霍乱传播。这些活动包括改善医疗卫生机构的饮用水、环卫和个人卫生措施，进行水质监测，向社区分发宣讲材料，以及促进保护性个人卫生习惯。

治疗

霍乱是一种易于治疗的疾病。大多数人可以通过及时口服补液成功治疗。严重脱水患者有休克危险，需要快速实施静脉输液。他们还要口服补液和服用抗生素。有基础性疾病或合并症的患者可能需要在特定治疗中心接受额外护理。治疗中心的病死率应保持在1%以下。

在霍乱疫情期间，社区得到口服补液溶液十分重要。不建议大规模使用抗生素，因为这对控制霍乱的蔓延并无实际效果，而且可能会助长抗微生物药物耐药性。

社区参与

社区参与涉及与人民和社区合作，制定和实施旨在满足其需求的规划。当地文化、做法和信仰对于促进保护性做法等行动至关重要，包括用肥皂洗手、安全制备和储存食物，以及安全处理粪便。可能需要改变霍乱死者的丧葬做法，防止葬礼参加者染病。社区应参与决定口服补液点的位置和其他社区控制干预措施。

社区参与对于就潜在风险、霍乱症状、为避免霍乱需要采取的防范措施、在何时何地报告病例以及出现症状时立即求治的重要性等问题进行有效沟通至关重要。

口服霍乱疫苗

目前，有三种经过世卫组织预认证的口服霍乱疫苗：Dukoral®、Euvichol-Plus®和Euvichol-S®。三种疫苗均需要接种两剂才能完全保护成年人。一剂Euvichol-Plus®或Euvichol-S®可提供良好的短期保护。Euvichol-S®于2024年通过世卫组织预认证，是Euvichol-Plus®的简化版本。Shancol疫苗已不再生产。

Euvichol-Plus®和Euvichol-S®不需要缓冲溶液，可用于一岁以上的任何人。这些是目前在全球疫苗免疫联盟支持下可通过全球口服霍乱疫苗库存用于大规模接种行动的仅有疫苗。自2022年10月起，由于全球疫苗持续短缺，且经免疫战略咨询专家组同意，目前采用仅接种一剂的方案。

怀孕期间口服霍乱疫苗是安全的。

[关于世卫组织口服霍乱疫苗政策的更多信息（英文）](#)

霍乱工具包

世卫组织开发了六种霍乱工具包，以支持调查和确认霍乱疫情以及治疗患者：

- 1种调查包；
- 1种实验室培养确认用品包；
- 3种面向社区、周边和中心层面的治疗工具包；以及
- 1种支持工具包，内有后勤物资，如太阳能灯、栅栏材料、水囊和水管。

每个治疗包的材料足以治疗100位病人。

[关于霍乱工具包的更多信息（英文）](#)

全球霍乱控制专题小组

全球霍乱控制专题小组是政府和非政府组织、联合国机构和学术机构的伙伴关系，其共同使命是减少全球霍乱负担。全球霍乱控制专题小组秘书处由世卫组织代管。全球霍乱控制专题小组合作伙伴致力于：

- 制定预防和控制霍乱的全球战略；
- 通过制定国家霍乱计划，支持各国长期控制或消除霍乱；
- 编写和分发技术指南和操作手册；
- 支持研究议程，评价受影响国家预防和控制霍乱的创新方法；以及
- 提高人们对霍乱作为重要全球公共卫生问题的认识。

[更多关于全球霍乱控制专题小组核心活动和进展的信息（英文）](#)

消除霍乱：2030年路线图

2017年，全球霍乱控制专题小组发布了《消除霍乱：实现2030年战略的全球路线图》。该战略旨在到2030年时将霍乱死亡减少90%，并在20个国家消除霍乱，措施包括：

1. 通过快速多部门反应及早发现和控制疫情；
2. 重点关注实施多部门干预措施的重点区域，即，受霍乱影响最严重的相对范围较小地区；以及
3. 在地方和全球各级建立有效的技术支持、宣传、资源调动和伙伴关系协调机制。

该战略在2018年第七十一届世界卫生大会上获得批准。

[关于该战略的更多信息（英文）](#)

世卫组织的应对

世卫组织霍乱规划致力于提高对霍乱的认识，并在全球倡导控制霍乱。在会员国一级，世卫组织支持各国霍乱控制工作的所有支柱，包括加强流行病学监测，加强实验室能力，改善治疗的可及性和质量，实施适当的水卫项目措施和感染预防控制做法，促进社区参与霍乱预防和控制，并促进口服霍乱疫苗的获得和大规模接种。世卫组织及其合作伙伴还支持研究制定预防和控制霍乱的创新策略。

世卫组织代管全球霍乱控制专题小组秘书处，也是国际疫苗供应协调小组应急疫苗储备协调机制的成员。

参考文献

1. Updated global burden of cholera in endemic countries. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4455997/> Ali M, Nelson AR, Lopez AL, Sack D. (2015). PLoS Negl Trop Dis 9(6): e0003832. doi:10.1371/journal.pntd.0003832.
2. The incubation period of cholera: a systematic review. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23201968> Azman AS, Rudolph KE, Cummings DA, Lessler J. J Infect. 2013;66(5):432-8. doi: 10.1016/j.jinf.2012.11.013. PubMed PMID: 23201968; PubMed Central PMCID: PMC3677557.
3. Cholera Annual Report 2023. Weekly Epidemiological Record, 9 September 2024, Vol 99 (36), (pp 481- 496). https://cdn.who.int/media/docs/default-source/dco/wer_36_2024_cholera-annual-report-for-2023_bilingual-proof.pdf?sfvrsn=86fb1faf_1